EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 69334
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-19 11:32:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: SANDRO ALBERTO MUNOZ MUNOZ			RUN	: 11.770.525-0
F.Nac	: 10-08-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: CURICO (#)
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-08-10	Fecha Egreso	: 2023-08-19 11:32:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.4-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA EN CEREBRO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-HIC tálamo-capsular y mesencefálica izquierda, ICH 0, obs origen venoso
-Obs ACV isquémico con TH

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I62-OTRAS HEMORRAGIAS INTRACRANEALES NO TRAUMATICAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Historia clínica
Paciente presento de forma súbita paresia braquiocrural derecha, cefalea y mareo, por lo que acude a SU, donde es evaluado por equipo medico y neurólogo con realización de TC de cerebro donde se evidencia HIC tálamo-capsular y mesencefálica izquierda, ICH 0. Por PA elevada ameritando manejo con bolos de labetalol; Neurología descarta manejo neuroquirurgico actual. En vista de clínica y riesgo de complicaciones se decide ingreso a unidad por 48hs para vigilancia clinica.
Paciente que se mantiene bajo monitoreo continuo, se ajusta terapia antihipertensiva logrando PA adecuadas, con mejoría de cuadro neurológico, con disminución de la disartria y déficit motor, es evaluado por neurologo dr venegas quien indica realizar rmn cerebral, y que paciente se encuentra en condiciones de traslado a cama basica. Sin complicaciones a nivel cerebral en control de tac.

Evolución
Paciente en BEG, HDN estable, eupneico, afebril, RS al monitor, refiere sentirse bien, niega molestias, sin fluctuaciones ni recurrencias, déficit en regresión significativa. Tolera bien alimentación VO, durante KNTM con regular estabilidad en bipedestación.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta el sábado posterior a RM cerebro.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio el 19/8/23 posterior a RM cerebro
-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control ambulatorio en policlínico Neurología

INDICACIONES AL ALTA

1. -Losartan 50 mg c/12h
2. -Lactulosa 30 cc c/8h si constipación

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación conservadas, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR, 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, atención N, OTE, lenguaje N, gnosias N, praxias N
-PC: CV impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, disartria muy leve, nistagmo(-), pares bajos impresionan N
-Motor: BC derecha M4-M4(+), BC izq M5, RCP extensor derecho y flexor izquierdo
-Sensitivo: hipoestesia táctil leve FBC derecha
-Cerebelo: conservado a izq, disdiadococinesia y dismetría proporcionales a paresia a derecha a braquial, impresiona desproporcionado a crural
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO